

		ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
		NS 22231696447	304
MASAHAKI SATO			
IDADE: 79	PESO: 58	ALTURA: 1,56	PROFISSÃO: Aposentado.
SINTOMAS:			
QUEIXAS: sonolência; Dorso;			
MEDICAMENTOS: 0			
MÉDICO:			
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N			
EXERCÍCIO FÍSICO: 0			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 23h30'		HORA QUE ACORDA: 06h30' dorme quanto	
COCHILO (X) S () N 2h		DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE separado.	
TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N		PET NO QUARTO: () S (X) N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: há 40 anos			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO/NOITE:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI: IV	IAH: 26,9	SPO2: 79%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Não - Faz Espironometria / usa correção aerobol			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA		() NEUROLÓGICA () OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N		SPO2 C/ CPAP: 84%	PRESSÃO NO EXAME: 7 cmH2O
Biologix 25/09/24		IAH = 14 cmH2O	
↳ IDO: 41 SpO2 min 81%			
07/10/24 Avaliação Auto 4 a 12 cmH2O máx Pico (C)			
(Auto 6 - 9 cmH2O)			
21/10 P = 8,7 cmH2O			
29 IAH = 4,8 efév			
m. de uso: 4h33'			
fuga: 8,9 lpmv. Jua			
04/11 P = 8,6 cmH2O			
29 IAH = 1,3 efév			
m. de uso: 5h30'			
Bem adaptado, porém, relata que a boca			
está seca. Jua			
25/11 P = 8,6 cmH2O			
29 IAH = 0,8 efév			
m. de uso: 5h17'			
Bem adapt., porém ficou alguns			
dias sl uso. Jua			
(R\$ 3200 → CPAP Resmed.)			

02/01 P= 8,6 cm H₂O
25 IAH= 0,8 e/ev
m. de uso: 4h43'
fuga: 37.2'

Aug.

30/03/25 P= 8,6 cm H₂O
IAH= 0,6 e/h
m de uso: 5h26'
fuga: 25,5 l/m

Plata retirar mascara
durante a noite
Natasha

27/03/25 P= 8,6 cm H₂O
IAH= 0,5 e/h
m de uso: 5h9'
fuga: 15,9 l/m

Bem adaptado
Natasha

25/05 P= 8,6 cm H₂O
25 IAH= 1.3 e/ev
m. de uso: 47.3 lpm

Bem adaptado
Jua claudia

Nome: MASAHAKI SATO

Data de Nascimento: 5-2-1945

IMC: 24,8

Sexo: Masculino

Data do exame: 25-02-2015

Peso: 62 kg

Altura: 1,58 m

Médico: DR. RICARDO RODRIGUES

CAVALCANTE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 25-02-2015, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

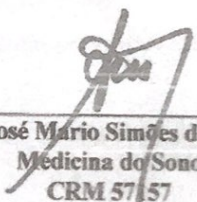
O tempo total de registro foi de 464,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 42,5 e 78,5 minutos. O tempo total de sono foi de 464,5, eficiência de 71,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 61,8%; estágio N3: 12,9%; sono REM: 22,4%. O índice de microdespertares foi de 11,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 26,9, sendo elas 90 obstrutivas, 0 mistas e 0 central e 59 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 79%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 67 bpm e NREM de 52 - 68 bpm. O paciente roncou intensamente.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 26,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado, com dessaturação acentuada.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MASAHAKI SATO
Data de Nascimento: 5-2-1945
IMC: 24,8
Sexo: Masculino
Data do exame: 12-05-2015

Peso: 62 kg
Altura: 1,58 m
Medico: DR. RICARDO CAVALCANTE
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-05-2015, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

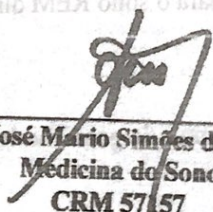
O tempo total de registro foi de 408,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 18,0 e 48,0 minutos. O tempo total de sono foi de 409,0, eficiência de 91,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 58,6%; estágio N3: 19,0%; sono REM: 20,7%. O índice de microdespertares foi de 10,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 14,4, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 central e 90 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 84%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 66 bpm e NREM de 56 - 65 bpm. O paciente roncou moderadamente.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 14,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2= 84%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco moderado durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP evidenciando melhor pressão terapêutica de 7 cmH2O.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157